

TEMA 9.55 • RESPIRATORIO

Generalidades de Cuerpo Extranño

PERFIL EUNACOM 2.09.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Relevancia Médico-Legal

El manejo de **cuerpos extraños (CE)** es una situación extremadamente frecuente en los servicios de urgencia, afectando a pacientes de todas las edades. Médicamente, un profesional puede realizar un examen físico adecuado, pero si un objeto (como un trozo de vidrio o una espina) permanece en el cuerpo del paciente, la percepción pública suele ser de **negligencia médica**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Mucho cuidado con los cuerpos extraños "invisibles". La persistencia de síntomas tras un trauma (dolor, inflamación, secreción) debe hacer sospechar un CE no diagnosticado, incluso si la radiografía inicial fue informada como normal.

Presentación Clínica

La clínica varía significativamente según la edad del paciente y la ubicación del objeto. Podemos dividir la presentación en tres grandes escenarios:

- **Historia Clara:** El paciente (o un testigo) relata exactamente qué ocurrió ("me tragué una moneda", "me entró un vidrio en el pie").
- **Sensación de Cuerpo Extranño:** El paciente no está seguro de qué ocurrió, pero siente "algo" en la garganta, el ojo o bajo la piel.
- **Sin Historia (Paciente de Riesgo):** Es el escenario más peligroso. Se da principalmente en:
 - Niños pequeños (*etapa de exploración oral*).
 - Pacientes con **déficit cognitivo** o enfermedades mentales.
 - Adultos mayores con *demencia*.
 - Pacientes bajo efectos de sustancias.

En estos casos, el diagnóstico depende de una alta sospecha clínica basada en síntomas indirectos (sialorrea, estridor, dificultad respiratoria, dolor localizado, infección persistente).

Clasificación por Radiopacidad

No todos los cuerpos extraños se ven en las imágenes convencionales. Esta distinción es fundamental para elegir el estudio diagnóstico correcto.

TABLA 9.55.1: TIPO DE CUERPO EXTRAÑO VS VISIBILIDAD EN RADIOGRAFÍA (RX)		
TIPO DE CUERPO EXTRAÑO	VISIBILIDAD EN RADIOGRAFÍA (RX)	EJEMPLOS COMUNES
Radiopacos	Alta visibilidad (blancos)	Metales (monedas, clavos), huesos de animales grandes, vidrio (la mayoría), piedras.
Radiolúcidos	Baja o nula visibilidad	Comida (el más frecuente en esófago), madera, espinas de pescado (algunas), plástico, grafito.

NOTA CLÍNICA

Aunque el **vidrio** suele considerarse radiolúcido en la cultura popular, la gran mayoría de los vidrios modernos tienen suficiente densidad para ser detectados en una Rx simple si se buscan dirigidamente. Por el contrario, la madera y el plástico son los "grandes ausentes" en las radiografías.

Cuerpos Extraños de Alto Riesgo

Existen ciertos objetos que, por su naturaleza física o química, representan una urgencia médica inmediata y requieren extracción

independientemente de los síntomas iniciales.

1. Pilas de Botón (Pilas de Litio)

Son quizás el CE más peligroso en pediatría. - **Mecanismo de daño:** Producen **quemaduras eléctricas** (corriente electrolítica) y químicas (liberación de hidróxido de potasio) que pueden perforar el esófago en menos de 2 a 4 horas. - **Manejo:** Extracción endoscópica de urgencia si están en el esófago.

2. Imanes

El riesgo aumenta exponencialmente cuando es **más de un imán** o un imán con otro objeto metálico. - **Mecanismo de daño:** Si se encuentran en diferentes asas intestinales, los imanes se atraen entre sí, atrapando la pared del intestino en el medio. Esto produce **isquemia, ulceración, necrosis y perforación**. - **Manejo:** Requieren vigilancia estricta o extracción quirúrgica/endoscópica.

3. Objetos Superabsorbentes

Juguetes o polímeros que crecen al contacto con el agua. - **Mecanismo de daño:** Pueden aumentar su tamaño original hasta 30-60 veces al hidratarse en el tracto digestivo, causando una **Obstrucción Intestinal** mecánica severa.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Ante la sospecha de ingesta de una **pila de botón** en el esófago, la conducta siempre es la **extracción inmediata**. Nunca se debe esperar a que "pase sola" debido al riesgo de fístula aorto-esofágica o perforación mediastínica.

Principios Generales de Manejo

- **Asegurar vía aérea:** Antes de evaluar el CE, verificar que el paciente no presente signos de **Obstrucción de Vía Aérea**.
- **Localización:** Determinar si el CE está en vía aérea, vía digestiva o partes blandas.
- **Estudio de Imágenes:**
 - **Rx simple:** Primera línea para objetos metálicos o sospecha de perforación (aire libre).
 - **TAC:** Útil para objetos radiolúcidos (plástico, madera) o para localización exacta en partes blandas antes de una cirugía.
 - **Endoscopia:** Es diagnóstica y terapéutica a la vez en vía digestiva alta.
- **Extracción:**
 - Si es un objeto peligroso (pila, imanes múltiples, objeto punzante).
 - Si hay compromiso hemodinámico o respiratorio.
 - Si el objeto no progresa espontáneamente tras un periodo de observación (en objetos romos no peligrosos).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca intente extracciones a ciegas en la faringe (maniobras digitales), ya que puede empujar el objeto más profundamente o causar una lesión mayor.

Enlaces Relacionados

- **Obstrucción de Vía Aérea por Cuerpo Extranño (OVACE)** - **Cuerpo Extranño en Vía Digestiva** - **Endoscopia Digestiva Alta** - **Urgencias Pediátricas**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un niño de 3 años es llevado a urgencias por su madre, quien refiere que lo encontró jugando con piezas pequeñas de un juego magnético y que ahora presenta dolor abdominal intermitente. La radiografía abdominal muestra dos cuerpos radiopacos en intestino delgado que parecen estar adheridos entre sí. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Generalidades de Cuerpo Extranero. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El cuerpo extraño es frecuente y tiene alta relevancia medicolegal
- La clínica puede presentarse con historia de cuerpo extraño o solo con sensación de tener algo dentro
- En niños y pacientes con déficit cognitivo puede no haber historia clara de ingestión
- Se clasifican en radiopacos (visibles en radiografía) y radiolucidos (no visibles, como alimentos y plástico)
- Las pilas producen quemaduras eléctricas y requieren extracción urgente
- Los imanes pueden adherirse entre sí causando ulceración o isquemia del tejido intermedio
- Los superabsorbentes (polímeros de juguetes) pueden crecer y obstruir, requiriendo extracción urgente
- Pilas, imanes y superabsorbentes siempre deben extraerse de forma urgente

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (GENERALIDADES DE CUERPO EXTRANERO)**PREGUNTA 1**

Un niño de 3 años es llevado a urgencias por su madre, quien refiere que lo encontró jugando con piezas pequeñas de un juego magnético y que ahora presenta dolor abdominal intermitente. La radiografía abdominal muestra dos cuerpos radiopacos en intestino delgado que parecen estar adheridos entre sí. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Observación clínica y control radiológico en 24 horas
- B)** Administrar laxantes para facilitar la expulsión espontánea
- C)** Extracción urgente por el riesgo de ulceración e isquemia del tejido interpuesto
- D)** Solicitar TAC abdominal para confirmar el diagnóstico antes de decidir
- E)** Indicar dieta rica en fibra y control ambulatorio en 48 horas

PREGUNTA 2

Un paciente de 2 años es traído a urgencias porque se tragó una pila de botón hace aproximadamente 2 horas. Se encuentra asintomático y la radiografía confirma la presencia de la pila en el esófago. ¿Cuál es el principal riesgo de este cuerpo extraño?

- A)** Obstrucción intestinal mecánica
- B)** Intoxicación por metales pesados
- C)** Quemadura eléctrica de la mucosa
- D)** Reacción alérgica al material metálico
- E)** Absorción de agua y crecimiento del objeto

PREGUNTA 3

Un niño de 4 años presenta tos leve y sensación de cuerpo extraño en la garganta desde hace unas horas, luego de comer pescado. La radiografía de cuello no muestra hallazgos patológicos. ¿Cuál es la explicación más probable de la radiografía normal?

- A)** El cuerpo extraño ya fue expulsado espontáneamente
- B)** La espina de pescado es un cuerpo extraño radiolucido que no se visualiza en radiografía simple
- C)** Se requiere una proyección lateral para visualizar el cuerpo extraño
- D)** La radiografía cervical no es útil en cuerpos extraños de vía aérea
- E)** El tamaño del cuerpo extraño es demasiado pequeño para ser detectado

RESUMEN: GENERALIDADES DE CUERPO EXTRANO

Esta clase aborda las generalidades del cuerpo extraño en la práctica clínica, enfatizando su alta frecuencia y su relevancia medicolegal. Un cuerpo extraño que pasa desapercibido puede ser motivo de demandas por negligencia médica, incluso si el actuar médico fue correcto en otros aspectos. La presentación clínica puede incluir una historia clara de ingestión o contacto con un cuerpo extraño (vidrio, espina, moneda, etc.) o bien solo la sensación de tener algo dentro. Es fundamental recordar que en niños y personas con déficit cognitivo o enfermedades mentales, puede no existir historia clara, lo que obliga al clínico a buscar signos específicos según la localización. Los cuerpos extraños se clasifican en radiopacos (visibles en radiografía) y radiolucidos (no visibles, como alimentos y algunos plásticos). Un TAC podría detectar los radiolucidos, aunque no siempre. Existen tipos especiales de alto riesgo: las pilas (producen quemaduras eléctricas), los imanes (dos imanes pueden adherirse entre sí y causar ulceración o isquemia del tejido interpuesto), y los superabsorbentes (polímeros de juguetes que absorben agua y pueden crecer obstruyendo la vía). Estos tres tipos requieren extracción urgente.